



FORUM DE CANCEROLOGIE DE ROCHE

DOUBLE BLOCAGE HER2, SYNERGIE PROUVÉE

TRAITEMENT NEOADJUVANT



www.forumcancerologie-roche.com



Cancer du sein précoce HER2+ à haut risque de récurrence

Les recommandations internationales préconisent **le traitement néoadjuvant** pour les cancers du sein précoces à haut risque de récurrence^{1,2}



Tumeur(s) >2cm | ou | ganglions+



Dans le traitement d'un cancer du sein de stade **précoce**, la taille de la tumeur, le grade, le statut des récepteurs hormonaux et les métastases des ganglions lymphatiques **doivent être pris en compte**³.

La combinaison PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB est recommandée pour le traitement néoadjuvant des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif précoce à haut risque⁴

NCCN

Lignes directrices du NCCN pour le cancer du sein (v4 - 2020)⁴

Les patientes présentant des tumeurs HER2-positives doivent être traitées par un traitement systémique préopératoire intégrant le trastuzumab.

Un schéma thérapeutique contenant du Pertuzumab en préopératoire peut être administré aux patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ précoce à haut risque de récurrence.

1. Cardoso F, et al. Ann Oncol 2019;

2. AGO Breast Cancer Guidelines. Version 1, 2020

3. Résumé des caractéristiques du produit PERJETA - Août 2020

4. NCCN Breast Cancer Guidelines. Version 4, 2020



Lignes directrices de l'ESMO pour le cancer du sein précoce (2019)¹

La double inhibition avec le trastuzumab-pertuzumab peut être envisagée chez les patientes à haut risque (à ganglions positifs ou ER-négatif) pendant 1 an, en commençant avant ou après la chirurgie [I, A; score ESMO-MCBS v1.1: B].



ARBEITSGEMEINSCHAFT
GYNAKOLOGISCHE
ONKOLOGIE E.V.

Lignes directrices de l'AGO (2020)²

Si la chimiothérapie est indiquée, le traitement systémique avant la chirurgie (néoadjuvant) doit être privilégié. **Le pertuzumab plus le trastuzumab en association avec la chimiothérapie est recommandé pour les patientes présentant un risque élevé de récurrence.**



Lignes directrices de Saint-Gall (2019)⁵

Le traitement systémique néoadjuvant est l'approche initiale privilégiée dans le cas du cancer du sein de stade 2 ou 3 surexprimant HER2 ou triple négatif. **La chimiothérapie en association avec le trastuzumab et le pertuzumab est l'approche privilégiée pour les tumeurs HER2-positives de stade 2 ou 3 en situation adjuvante et néoadjuvante.**

Open access

Editorial

ESMO Open

Cancer Horizons



Check for updates

Traitement néoadjuvant des cancers du sein HER2-positifs et triple-négatifs à risque intermédiaire/élevé : ce n'est plus une «option», mais une obligation éthique⁶

1. Cardoso F, et al. Ann Oncol 2019;

2. AGO Breast Cancer Guidelines. Version 1, 2020

5. Burstein HJ, et al. Ann Oncol 2019.

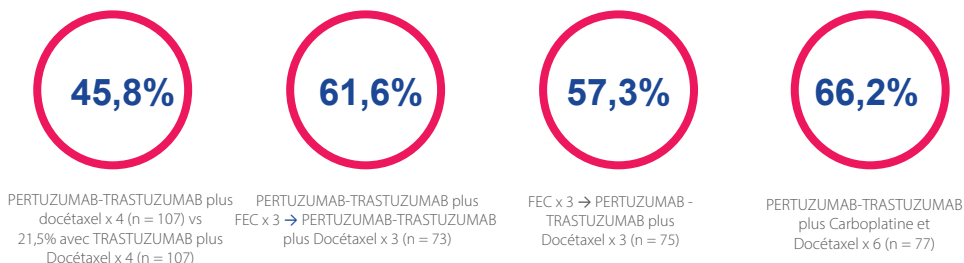
6. Brandão M, et al. ESMO Open 2019;4:e000515.doi:10.1136/esmoopen-2019-000515

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB le traitement néoadjuvant de référence pour les cancers du sein HER2+ à haut risque de récurrence¹

Réponses pathologiques complètes (rPC)

- 39,3-63,6% des patients ont obtenu une rPC avec **PERTUZUMAB -TRASTUZUMAB** en néoadjuvant plus chimiothérapie^{8,9}

Taux de rPC au moment de l'intervention chirurgicale^{7,8}



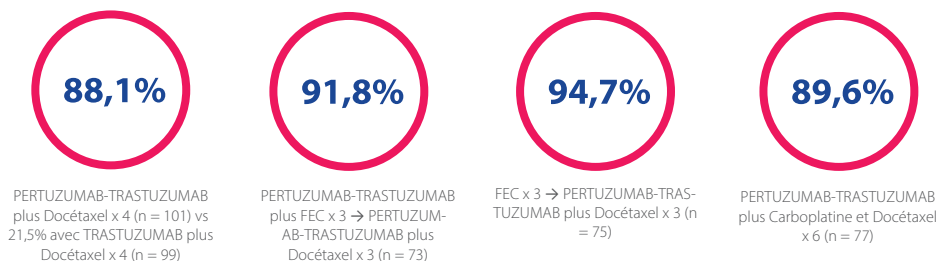
NeoSphere ————— TRYPHAENA*

L'ajout de PERTUZUMAB a significativement augmenté le taux de rPC dans le sein par rapport à TRASTUZUMAB plus chimiothérapie (p = 0,0141)⁷

Réponses cliniques

- 88,1-94,7% des patients ont présenté une réponse clinique avec **PERTUZUMAB - TRASTUZUMAB** en néoadjuvant^{7,8}

Taux de réponse clinique au moment de l'intervention chirurgicale^{7,8}



IC 95%: 80,2-93,7
NeoSphere

TRYPHAENA*

*Pour plus d'informations veuillez consulter l'article original

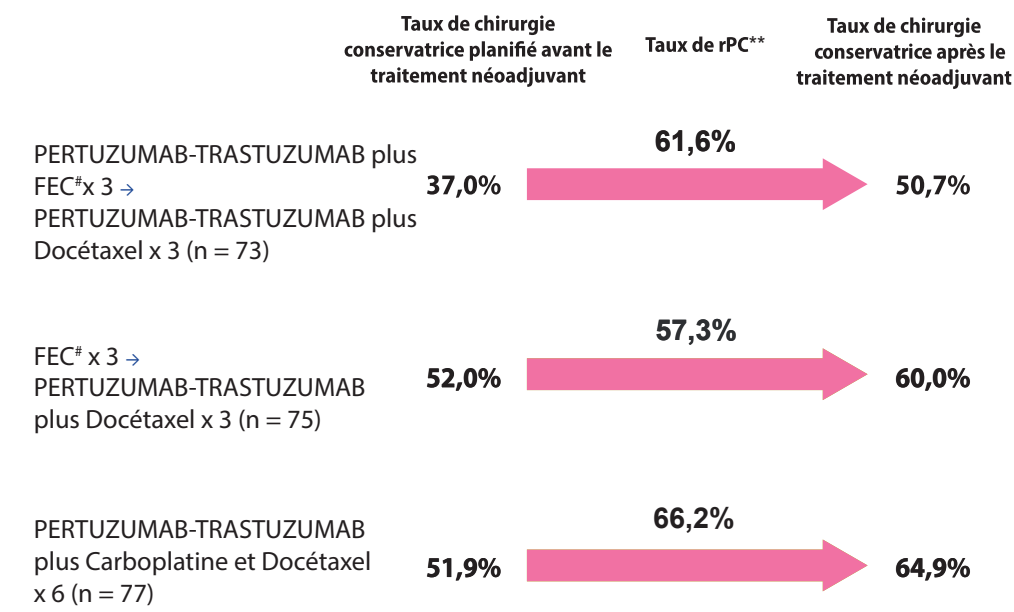
1. Cardoso F, et al. Ann Oncol 2019

7. Luca Gianni, Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2012; 13: 25-32

8. A. Schneeweiss, Pertuzumab plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer: a randomized phase II cardiac safety study (TRYPHAENA). Annals of Oncology 24: 2278-2284, 2013

Chirurgie conservatrice du sein*

- Le traitement néoadjuvant par **PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB** a augmenté le taux de chirurgie conservatrice du sein de 8,0-13,7% par rapport à ce qui était initialement prévu²



*Pour plus d'informations veuillez consulter l'article original
**rPC: reponse pathologique complète. #FEC: 5 Fluorouracil, Epirubicine, Cyclophosphamide

8. TRYPHAENA: A. Schneeweiss, Pertuzumab plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer: a randomized phase II cardiac safety study (TRYPHAENA). Annals of Oncology 24: 2278– 2284, 2013

Pour toute déclaration d'évènements indésirables merci d'envoyer un mail à Roche Côte d'Ivoire Sarl au global.irt_sahubtcs@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55

Pour toute demande d'information médicale merci d'envoyer un mail à westafrica.medinfo@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55.

ROCHE Côte d'Ivoire SARL

Ivoire Trade Center, Cocody les ambassades Angle de la rue Hassan 2 et de la rue Booker Washington,
Bâtiment D 1er étage
18 BP 2377 Abidjan 18, Côte d'Ivoire
Tél : +225 27 22 48 23 55

M-CI-00000275